Diarreia · Cartão de Plantão

Para consultar à beira do leito; confira no protocolo do serviço

Classificar [MS]

	A	B	C
Geral	Alerta	Irritado	Letárgico*
Olhos	Normais	Fundos	Fundos
Sede	Sem	Bebe ávido	Não bebe*
Lágrimas	Sim	Não	Não
Boca	Úmida	Seca	Muito seca
Prega	Imediata	Lenta	> 2 s
Pulso	Cheio	Cheio	Fraco*
Peso	—	≤ 10%	> 10%

B: ≥ 2 sinais. C: ≥ 2 com ao menos 1 *. Dúvida: pior cenário.

Plano A [MS]

Líquido após cada evacuação: < 1 a 50–100 mL · 1–10 a 100–200 mL. Alimentação habitual. **Zinco** 10 mg/dia (≤ 6 m) ou 20 mg/dia (6 m–5 a), 10–14 dias. Voltar se piorar, vômitos, sangue, pouca urina, muita sede, recusa, 2 dias sem melhora.

Plano B [MS]

SRO **50–100 mL/kg (média 75)** em 4–6 h, no serviço. Vômito persistente: ondansetrona 2 mg (6 m–2 a) · 4 mg (> 2–10 a, ≤ 30 kg) · 8 mg (> 30 kg). Segue desidratado: gastróclise. **6 h sem melhora: internar.**

Plano C · expansão [MS]

< 1 ano	30 mL/kg em 1 h → 70 mL/kg em 5 h
≥ 1 ano	30 mL/kg em 30 min → 70 mL/kg em 2 h 30
Cardiopata grave, RN	Começar com 10 mL/kg

SF 0,9% ou Ringer lactato. SRO junto quando puder beber (2–3 h). Observar ≥ 6 h.

Plano C · 24 h [MS]

Manutenção	SG 5% + SF 4:1 · ≤ 10 kg 100 mL/kg · 10–20 kg 1.000 + 50/kg acima de 10 · > 20 kg 1.500 + 20/kg acima de 20 (máx. 2.000)
Reposição	SG 5% + SF 1:1, 50 mL/kg/dia, ajustar às perdas
Potássio	KCl 10% 2 mL / 100 mL da manutenção, com K e função renal conhecidos

Disenteria com estado geral comprometido [MS]

≤ 30 kg, ≥ 3 m, sem imunodeficiência	Azitromicina 10 mg/kg D1 + 5 mg/kg/dia D2–D5 · alt.: ceftriaxona 50 mg/kg IM 1×/dia, 3–5 dias
> 30 kg	Ciprofloxacino 500 mg 12/12 h, 3 dias
< 3 m ou imunodeficiente	Ceftriaxona 50–100 mg/kg EV 1×/dia; fora do hospital, 1ª dose IM e referir
48 h com sangue	Até 10 anos: internar

Amebíase: metronidazol 50 mg/kg/dia 8/8 h, 10 dias · giardíase: 15 mg/kg/dia 8/8 h, 5 dias.

Não prescrever

Antibiótico de rotina na diarreia aquosa (exceto cólera grave) · antidiarreico · refrigerante · dieta restritiva · suspender o leite · ondansetrona em gestante.